

EFT 督導模式的基本向度：能力、目標、督導者回應與事件本位模式

對應原書：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. 第2章 The Essential Dimensions of the Emotion-Focused Therapy Model of Supervision (pp. 29–43) 本檔內容：學習目標 | 完整學術摘要 | 核心概念洞見 | 關鍵原文引述 | 臨床推理框架

標示說明：「原教材指出」表示內容直接來自原書；「從臨床實務角度」表示本教材的延伸詮釋。文中的例句除非註明為原書例子，否則均為綜合改寫的簡短示意。

本單元學習目標

完成本單元後，你能夠：

1. 能描述 EFT 五大能力向度與五項督導目標，並為自己擬定一個以能力向度為架構的督導學習目標。
〔應用／反思實務〕
2. 能分類一段督導對話中每一則督導者回應，歸入四類回應（同理探索／歷程引導及其五種子類型／經驗性在場／內容指導）。〔分析／介入〕
3. 能判斷何時必須暫停經驗性督導，改用內容指導回應（例如自殺風險、界線議題），並寫出一段合乎倫理的督導指導語。〔評鑑／倫理〕
4. 能將一次督導晤談切分為五步驟事件序列（接觸→標記→任務環境→受督者歷程→解決），並指出該事件屬於人際、技術或督導同盟困難。〔分析／反思實務〕
5. 能辨識受督者標記的四種來源，並以受督者身分準備一個具體的督導標記帶進督導（含錄影時間點）。〔應用／反思實務〕
6. 能說明為何「受督者歷程才是改變的所在」，並評估一次未解決的督導事件可能如何演變成同盟裂痕。〔評鑑／治療關係〕

§2 完整學術摘要

A. 主題與背景

本章要回答的問題

第1章說明了 EFT 督導建立在什麼理論與原則上。第2章接著回答：EFT 督導實際上由哪些部分組成？一次督導是如何展開的？原教材在本章提出三個基本向度：

1. EFT 的能力與督導目標：督導要培養什麼？

2. 督導者的介入風格，也就是參與方式：督導者用哪些回應來促進學習？
3. EFT 事件本位督導模式：一次督導事件由哪些步驟構成？

模式的定位

原教材指出，這是一個以歷程為本的督導取向（參照 Bernard & Goodyear, 2013）。它有兩個來源：

- 任務分析取向：Greenberg（1984）用來理解心理治療改變事件的方法；
- 事件本位典範：Ladany、Friedlander 與 Nelson（2005, 2016）提出的督導研究架構。

模式的一般描述包括四個部分：標記、任務環境、受督者歷程、任務解決。EFT 督導的主要組成是督導同盟、受督者的人際技能、技術技能與個人化議題，這些在後續章節詳細展開。

作者對這個模式的期待有三層：讓督導地圖更清楚；成為辨識、理解並最終研究督導關鍵成分的範本；以及讓督導者與研究者都能使用。

為什麼這對碩士生重要（從臨床實務角度）

了解督導的結構，受督者就能從「被動接受指導」轉為「主動參與督導」：知道要帶什麼進督導（一個標記）、知道自己此刻的困難屬於哪一類，也知道什麼樣的結果算是這次督導有了進展。

B. 核心概念與重要定義

B1. 為什麼要明確界定能力與目標

原教材指出，清楚界定核心能力與督導目標有兩個功能：

- 讓督導者能系統性地組織與概念化大量資訊，使目標得以達成、能力得以發展；
- 讓督導者與受督者有共同基礎，一起決定督導中最重要的面向，並選擇性地聚焦於這些面向。

B2. EFT 的五大能力向度

能力向度	原教材的內容	在實務中看起來像（從臨床實務角度）
① 關係能力	建立並維持正向、成長導向、真誠的治療關係；具體表現為在場、個人溫暖、同理與慈悲	個案感到被理解、願意說出更多
② 態度能力	真誠的好奇；正向的人性觀（所有人無論處境如何，都值得被愛與尊重）；相信改變可能發生。其他目標態度包括：對經驗開放、高度容忍模糊、提升自我覺察與社會覺察（例如欣賞多元、正直）	面對不確定的概念化時，不急著下結論
③ 技能能力	四類：(a) 知覺、概念與介入技能；(b) 表達技能：傳達同理、投入他人、讓人自在、建立關係、傳達尊重；(c) 歷程技能：調頻的傾聽、歷程診斷與概念化技能；(d) 進階介入技能：完成不同治療任務所需的技能	能說出適合的回應，也知道何時說

能力向度	原教材的內容	在實務中看起來像（從臨床實務角度）
④ 情緒能力	覺察情緒，並讓情緒為合理的行動提供資訊。包含情緒覺察、情緒運用、情緒知識、情緒管理：覺察自己與他人的情緒；取用或產生感受以促進思考；忍受情感；理解情緒；調節自己與他人的情緒以促進成長	個案崩潰時，治療師能穩住自己
⑤ 知識能力	包括 EFT 與情緒文獻的專業知識，但最重要的是對自己與他人的認識	知道自己在哪些情緒面前容易退縮

與相關概念的區分：這五個向度不是彼此獨立的清單。例如「情緒能力」中的忍受情感，直接影響「關係能力」中的在場（從臨床實務角度）。

常見誤解：以為 EFT 訓練只在教技術。原教材把態度與情緒能力列為獨立的能力向度，而且把「對自己的認識」視為最重要的知識。

B3. EFT 督導的五項目標

1. 成長導向、真誠、信任的關係：協助受督者建構心理治療的價值，並依這些價值發展專業認同。
2. 提升臨床能力：以受督者的優勢為基礎，改善其弱點。在督導關係的安全中，協助受督者：
3. (a) 提升人際技能，例如與個案形成連結、維持合作同盟；
4. (b) 發展並運用歷程診斷技能，例如辨識治療標記、與個案合作朝向任務；
5. (c) 發展技術技能，例如在對話中的介入、概念化與個人化技能；透過跟隨與引導個案達成共構；
6. (d) 發展情緒促進技能，例如提升知覺、取用、理解、調節與轉化情緒的能力；並提供受督者日後自己擔任督導者的經驗基礎。

原教材也指出，督導者明白整體督導經驗都在影響受督者的態度與技能發展，因此督導者會示範所教的內容：情緒覺察、同理、批判思考與成長。3. 維護個案福祉並促進個案改變：始終以個案的最佳利益為念，協助個案朝向解決困難，達到更符合內外安適狀態的調適。4. 確保合乎倫理的專業實務：確保個案的安全與最佳臨床結果。5. （依場域而定）評量表現：若督導者負有評量責任，就監督受督者的發展程度與進入下一階段訓練的準備度，並提供形成性回饋。

B4. 討論督導目標時的兩個重要面向

第一，關係面向是首要的。原教材指出，督導的關係面向對建立督導同盟、作為合作工作的基礎是最重要的。督導經驗是兩個人之間的相遇，雙方在持續的「我—汝」（I-Thou）對話中轉化彼此，也被彼此轉化（參照 Buber, 1958）。這是關係經驗的面向。然而，個案的治療仍然是雙方在一起的核心目的，督導中應該實質地促進個案的福祉，這構成督導技術性、目標導向的面向。

第二，評量能力的問題。原教材的立場是：受督者的學習、成長與發展，優先於對其進展的正式評量，以提供最佳的學習環境。依據「每個人都擁有成長的內在資源，這些種子需要沃土」的信念，確保安全、促進性與創造性的環境是必要的。

EFT 督導不是什麼：

不是	原教材的說明
個案回顧	督導不是回顧個案資料，而是以錄影中的實際歷程為焦點
對受督者的替代性治療	督導不以治療受督者在晤談中被觸發的個人議題為焦點
權威、僵化的指導	不像某些手冊化治療在執行與遵從手冊時那樣，權威而僵化地指導受督者的做法（參照 Ladany et al., 2005）

督導者的主要角色是提供支持與溫和的引導，並推進受督者學習促進個案經驗與情緒處理的方法。

B5. 督導者的四類回應（參與方式）

原教材指出，EFT 督導者偏好的參與方式，是對受督者及其對個案與治療歷程的擔憂做出經驗性回應，並協助探索受督者的兩難。督導者使用以下四大類回應（參照 Elliott, Watson, Goldman, & Greenberg, 2004）：

① 同理探索回應

- 功能：傳達理解，同時協助受督者從不清楚、正在浮現的邊緣，更清楚地感覺到個案在溝通、感受與需要什麼。
- 五種形式：探索性問句、契合問句（fit questions）、歷程觀察、同理臆測、同理重新聚焦。
- 原書示例：「我看到你對個案的回應是在驗證那份痛，而不是個案聲音裡的憤怒。我好奇那一刻發生了什麼，是什麼讓你這樣決定？」

② 歷程引導回應

- 核心：引導歷程，而非內容。直接告訴受督者要做什麼，違反任務合作與自我發展的原則。督導者提供的是關於如何在特定治療任務上有成效地工作的建議。
- 五種子類型：

子類型	原教材的定義
(a) 經驗性概念化	協助受督者以經驗性的語彙概念化個案的議題
(b) 書籤標記 (bookmarking)	標出某個經驗或任務值得日後注意與處理
(c) 經驗性教學回應	提供關於經驗或治療歷程本質的資訊
(d) 結構化任務回應	提出可能的任務，或建議如何進入、完成手邊的任務
(e) 歷程建議	教練式的活動，鼓勵治療師在晤談中嘗試特定的介入，例如澄心聚焦、椅子工作

- 原書示例（結構化任務回應）：督導者注意到受督者大量依賴同理回應，於是說：「我喜歡你傳達同理的方式，但我覺得你需要在回應中多一些結構，並把我們的任務放在心上。你可以轉向椅子工作，喚起個案對失落的情緒。」

- 覺察作業：督導者有時會請受督者分析自己晤談錄影的片段，辨識標記、個案的情緒反應、可能的任務與相應的介入回應，以更掌握治療中的微歷程。

③ 經驗性在場回應

- 形式：通常透過調頻、珍視、真誠與合作來傳達，目的是培養督導同盟。
- 兩種揭露：另外兩種傳達在場的方式，被當作教學手段：
- 歷程揭露：例如表達對受督者某個介入的興奮；
- 個人揭露：運用個人或專業上的例子與經驗。
- 原書示例：聽錄影時的小小鼓勵，例如「傾聽和跟隨得很好」「太好了！」「我喜歡這個！」

④ 內容指導（非經驗性）回應

- 形式：問題解決式的建議、專家式的保證、資訊性問句。
- 原教材的立場：儘管有「最少內容指導」的原則，這類回應仍然無可避免。任何督導都涉及一定程度的個案管理，督導者在實務議題上必須扮演建議者或協調者，例如：
- 執行倫理行為；
- 建立治療設置；
- 處理個案的自殺風險或嚴重情緒調節不良。
- 面對自殺風險或界線違反（例如個案不出席、付費問題、送貴重禮物）時，督導者首先關心的是提供受督者指引，以及處理這些議題的具體方法。
- 原書示例（自殺風險）：督導者先要求在晤談中做簡要評估，並具體詢問：個案除了想死的幻想，是否還知道其他資訊？這些念頭是主動或被動？多常出現？有沒有計畫？考慮用什麼手段？有哪些保護因子？

從臨床實務角度：這一點對碩士生特別重要。EFT 督導重視跟隨與經驗性探索，但遇到風險與倫理議題時，督導會轉為直接、具體的指導。這不是風格不一致，而是依優先順序做判斷：個案安全先於歷程學習。受督者也應主動在督導開頭提出這類議題，不要等到最後才說。

B6. 從團體督導經驗取向改編的技術

原教材把 Glickauf-Hughes 與 Campbell（1991）提出的經驗性團體督導取向，改編進 EFT 督導框架。該取向融合了不同理論的督導技術：平行歷程、對話、以自我為工具、督導者作為治療師、角色扮演。原教材說明了以下幾項：

- 對話：基於「受督者必須學會從內在發現真理」的認識，督導者要在受督者的參照架構中提問，而不是在督導者的參照架構中提問。例如問「你怎麼想？」，而不是說「就是這樣。」督導者不直接回答受督者的問題，而是用提問協助受督者得出個人化的答案，鼓勵受督者信任自己的感受、知覺與介入。

要讓對話發揮效果，督導者需要敏感於三件事：受督者的理論框架（受督者可能先受過認知行為或心理動力取向的訓練）；受督者的個人、文化與專業生命視角；並找到雙方共通的語言。 - 以自我為工具：督導者關注受督者經驗性地使用自己的能力，把受督者在晤談中的感受當作個案可能發生什麼的指標。督導者協助受督者辨識自己在與個案互動的不同時刻感受到什麼，深化這些感受並從其意義中學習，讓受督者更覺察自己的感受，並把它們用在治療目的上。 - 歷程建議與微歷程引導：除了這些較偏跟隨的

回應，督導者也透過歷程建議來引導：不同的回應方式、似乎正在出現的標記、可以使用的介入。督導中有大量微歷程引導，建議可以用什麼介入來深化經驗與情緒處理。 - 示範：在督導中現場示範某個介入或治療回應。示範不只透過直接演示，也發生在態度層次：督導者如何對待受督者、如何看待個案的困難，本身就是一種教學，也是受督者建立技能的基礎。

B7. EFT 事件本位督導模式

原教材指出，這個模式以事件本位的任務分析典範為基礎，用具體的方式說明督導的關係與歷程。它被設計為一個對督導者與研究者都有啟發性的工具，以標記、任務環境、學習（或改變）歷程與解決來具體描述不同的督導成分。

基本假設：EFT 督導是由一系列督導事件組成的歷程。每個事件都有可辨識的開始、中間與結尾，並且鑲嵌在同理的合作關係中。

每個事件的五步驟序列：

步驟	內容
(a) 建立關係接觸	督導從關係接觸開始
(b) 辨識標記	辨識受督者問題狀態的標記
(c) 建立任務環境	督導者建立可能協助受督者處理問題的任務環境
(d) 受督者歷程	受督者在學習新事物時的處理歷程，也就是改變或學習的歷程
(e) 解決	問題狀態的解決

標記決定督導的主要焦點。焦點可能是：

- 人際或同盟困難：受督者與個案之間，或受督者與督導者之間；
- 技術困難：受督者在某項介入技能上遇到困難。

時間尺度：解決代表一個特定事件的結束。許多事件可以在一次督導中開始並完成；其他事件可能延續一段時間，在多次督導中解決（或未解決），甚至持續整個督導歷程。

原教材的核心比喻：督導和治療一樣，是「在同理支持與驗證之海中的工作之島」（p. 37）。

B8. 圖 2.1：EFT 督導任務擴展模式

原書以圖 2.1 呈現整體模式，列出不同類別的受督者困難、介入技能與解決。依原圖可辨識的內容整理如下（原圖為流程圖，本表為改寫重構）：

接觸 →	標記	任務環境	改變歷程	解決
關係接觸	A. 受督者提出的困難：人際（低同理、同盟弱）；技術（介入、個案概念化） B. 督導同盟困難：對質、退縮；另列個人化	督導者的操作（督導者的角色與風格）：同理探索、經驗學習對話、示範、角色扮演	受督者歷程：投入	(a) 督導同盟改善：雙方積極而有成效地投入督導關係 (b) 技能提升：人際技能（同理、傳達 Rogers 核心條件的能力）；技術技能（知識提升、使用新介入、理解個案的核心情緒基模、發展個人的介入風格）

註：原圖經文字辨識後部分排版失真，上表只收錄可以明確辨識的項目。

B9. 步驟一：關係接觸

- 原則：督導總是從關係接觸開始，接著詢問受督者希望督導者聚焦在什麼，除非初始接觸中浮現了更緊急的議題。通常（但不總是），受督者會就某些點或困難請求協助。
- 督導事件的定義：聚焦在受督者與個案晤談中的行為表現，發生在督導者與受督者已發展出的關係這個特定脈絡中，並發生在督導的特定時間點（早期、中期或後期）。
- 錄影要求：因此，所有督導都應使用晤談錄影，最好是影像錄影，讓受督者的實際表現成為督導的焦點。
- 接觸的具體做法：督導者歡迎受督者進入督導空間，營造友善安全的氛圍，簡短交流受督者目前的狀況、心理狀態、精力，或任何可能成為這次督導阻礙的事。這也表示「先接觸，再訂契約」：先接觸，再透過討論目標、合作協議督導焦點來訂立「契約」，焦點可以是一般性的，也可以針對特定一次督導。
- 原書示例：督導者可能這樣開場：「嗨，很高興你又來了。今天感覺怎麼樣？感冒好一點了嗎？」
- 接觸之後進入工作階段，開始聽晤談錄音。受督者可能說：「感冒好多了，謝謝。上次跟個案的晤談中，有件事讓我一直在想。」督導者也可能問：「今天想談什麼？」或「上次晤談發生了什麼，是你想談的？」
- 督導者的準備：在督導前或開始時，督導者先清空自己，放下先前在做的事，或擱置無關的擔憂，以盡可能在場。
- 新個案的背景資料：若焦點是新個案，督導者會詢問背景資訊、主訴、個案史、一些人口學資料，以及晤談中發生了什麼。但這些資料只作為對個案與晤談的定向，不是督導的依據，因為督導永遠是透過聽錄影或看影像中的歷程來進行。

B10. 步驟二：標記辨識

標記的定義：督導事件的標記，是受督者的陳述或行為，顯示出受督者想要聚焦的某件事。它通常在督導早期出現。

標記的四種來源：

來源	原書示例
① 受督者的兩難	「我該做椅子工作，還是澄心聚焦？」
② 受督者語言或非語言的擔憂	「我擔心我漏掉了這位個案呈現中的某些東西。」談到某議題時在椅子上不自在地挪動
③ 受督者直接請求協助	「今天我想聚焦在我的椅子工作技術上，我不確定我真的掌握了。」
④ 督導者辨識出的教學點	督導者在錄影中看到可以受益於特定介入的個案狀態，例如受督者沒有注意到或沒有處理的標記、治療任務、情緒反應或情緒底音

受督者在治療中的困難有兩類：

類型	原書示例
人際困難（與個案）	「我就是覺得沒跟個案連結上，沒理解他。」「個案看起來很戒備。」
技術困難（介入）	「我好像沒辦法幫個案深化感受。」「我不知道怎麼幫個案把憤怒說出來。」（在自我批評對話中）「我抓不到個案核心的批評。」

這些困難也可以由督導者觀察到。受督者與督導者也可能同時辨識出多個擔憂，例如與個案的同盟困難、缺乏治療焦點、難以辨識歷程標記。這時先處理哪一個，由雙方合作決定。

另一類標記：督導同盟困難。受督者與督導者之間的同盟困難可能表現為：

- 同盟裂痕：受督者對質督導者，表達對督導的不滿；
- 其他形式：受督者退縮、無助、防衛或對立。

此外，有些情況下督導者覺得需要對質受督者的行為，例如遲到，或某項正在干擾治療的特定個人或技術弱點。

B11. 步驟三：任務環境

- 定義：任務環境是督導者在標記處所做的回應，用來讓受督者投入某項督導任務。
- 原書示例：協助受督者持續聚焦於個案的核心議題；教受督者解決一段未竟事務所需的步驟。
- 督導者的表現就是任務環境。在這一步，錄影中受督者的介入或同理回應，或受督者向督導者陳述的困難，之後接著督導者的引導；雙方合作處理這個任務，以達成期望的解決。
- 錄影的角色：在錄影中辨識出標記之後，督導者會聽或看晤談片段，因此有機會「直接」見證個案與治療師之間的互動與表現：個案與受督者實際說了什麼、怎麼說、接下來的回應是什麼。
- 研究的焦點：值得關注的督導者操作，是那些為了處理督導任務而做的回應與介入。

B12. 步驟四：受督者歷程是改變的所在

這是本章最重要的主張之一。原教材指出：

- 督導者的介入要有效，必須促進受督者的投入與發展歷程。

- 因此，督導中受督者的歷程才是改變的所在，比督導者做了什麼更重要。
- 成功的督導取決於督導者能否促進受督者的學習。受督者的歷程帶來新能力的習得，進而提升臨床技能。
- 新能力可能是新的知覺、介入或概念技能。

原書的三個例子：

技能類型	例子
知覺技能	受督者開始在聽覺上聽見個案聲音品質的改變，那表示個案正進入更鮮明、更觸動的經驗。這需要受督者能在聽覺上與概念上區辨不同的個案發聲模式
介入技能	受督者學會協助個案深化經驗的新方法，例如習得讓個案聚焦於當下身體感受的新技能
概念技能	受督者更理解個案常把自己的自我批評歸因於他人，並把這些投射經驗為對方對他這樣做。這個理解由雙椅對話，以及督導者指出個案正在這樣做，共同促成

原教材承認的限制：受督者身上這些複雜的認知、情感與行為歷程，如何導致他們存在、觀看與做事方式的改變，尚未被清楚研究或界定。

B13. 步驟五：解決

定義：解決代表督導任務的成功結果或達成，可能在督導中逐步建立，也可能在督導結束時發生。

解決的兩種形式：

- (a) 督導同盟改善：雙方積極而有成效地投入督導關係；
- (b) 技能提升：
 - 人際技能提升：更在場，有更好的同理、溫暖、正向關懷與一致性；
 - 技術技能提升：能使用新介入，理解個案的核心情緒。

成功督導的結果：新的理解；知覺、理解、態度與技能的整合；行動計畫等等。受督者在以下五個領域之一發展、精煉並實踐新技能：

領域	原教材的描述
治療同盟	更能積極而有成效地投入治療關係
知覺技能	以新的方式看見個案的表現與經驗
個案概念化	對個案的主題與運作模式發展出有洞察的理解
介入技能	更能及時、流暢、有創意地使用新介入
個人化	感到被鼓勵、被啟發而成長

原書示例：解決可能是受督者對個案的憂鬱組織產生經驗性的新理解：看見次發的無望與悲傷可能遮蔽了底下的憤怒，並對核心憤怒的適應面發展出新的看法。

解決的主觀指標：解決或朝向解決的進展，會被雙方經驗為鬆一口氣與滿足，並帶著重新燃起的熱情，繼續為個案工作。

未解決的情況：解決不一定在某次督導中達成，也可能在後續督導中才完全達成。較不成功的督導，依定義就是沒有解決或沒有朝向解決的進展。未解決的督導任務會在後續督導中反覆出現；若持續未解決，督導同盟裂痕的危險就迫在眉睫。這時必須公開、真誠地討論彼此的目標與期待，並依對困難的新理解，重新組織與調整任務。

C. 理論架構／概念模型

C1. 事件模型的流程

一個「工作之島」，永遠位於「同理支持與驗證之海」中：

關係接觸 →	標記 →	任務環境 →	受督者歷程 →	解決
先接觸，後契約；確認焦點	4 種來源；人際、技術或督導同盟困難	督導者 4 類回應；對話、以自我為工具、示範	知覺、概念或介入技能的習得	同盟改善，或 5 個領域的技能提升

若未解決：反覆出現 → 督導同盟裂痕的風險 → 公開討論目標與期待，重新組織任務。

C2. 與治療的平行關係（從臨床實務角度）

治療中	督導中
個案標記（例如未竟事務）	受督者標記（例如「我抓不到核心批評」）
治療任務（例如空椅對話）	督導任務（例如示範、角色扮演、練習回應）
個案的改變歷程	受督者的學習歷程
解決（例如原諒或追究責任）	解決（同盟改善或技能提升）
同理之海中的工作之島	同理支持之海中的工作之島

D. 實證基礎

主張	證據性質	強度與限制
以任務分析理解改變事件	Greenberg（1984）的方法論	在心理治療改變研究中有發展基礎；用於督導是本書的提議
督導事件可以被辨識、探索並解決	Ladany、Friedlander 與 Nelson（2005, 2016）的事件本位模式	第6章說明這是分析督導逐字稿所得；不是針對 EFT 督導的研究

主張	證據性質	強度與限制
五步驟事件模型	作者提出的啟發性模式	本章沒有實證檢驗；作者定位為「範本」，供日後研究
受督者歷程是改變的所在	理論主張	作者自承受督者的學習歷程尚未被清楚研究
內容指導回應在風險情境不可避免	專業實務共識與倫理要求	屬於實務與倫理立場，不是實證發現

結論：第2章提出的是一個結構化的概念模式，它的價值在於提供共同語言與研究架構，而不是已驗證的效果。

E. 臨床意義

面向	本單元的意涵
受督者的準備	帶一個具體標記進督導：錄影時間點、你的困難、你想要什麼樣的協助
督導的結構	先接觸，再訂契約；困難屬於人際、技術或督導同盟中的哪一類，會決定任務環境
評估受督者的能力	五大能力向度提供全面的評估架構，不只看技術
風險管理	自殺風險、嚴重情緒調節不良、界線議題時，督導轉為內容指導；受督者應及早提出
督導關係	學習優先於評量；督導不是個案回顧，也不是替代性治療
督導成效	以受督者的學習歷程與解決指標（鬆一口氣、滿足、重燃熱情）判斷，而不是看督導者講了多少
同盟維護	反覆出現的未解決議題是裂痕的預警，需要公開討論

F. 臨床推理：督導者在標記出現時如何思考？

以受督者說「我不知道怎麼幫個案把憤怒說出來」為例：

1. 應蒐集哪些資訊？錄影中的實際片段；受督者嘗試過什麼；個案的聲音與非語言表現；受督者自己在那一刻的感受。
2. 可能的假設：
3. 技術困難：不知道介入步驟；
4. 知覺困難：沒聽出憤怒的線索；
5. 人際困難：同盟不足以承受憤怒；
6. 受督者自身的情緒能力：對憤怒不自在。

7. 替代解釋：個案的憤怒可能還不是此刻的主要情緒，受督者的判斷可能其實是對的；或者文化表達規則影響了個案。
8. 支持或削弱各假設的資料：看錄影時，受督者能不能指出憤怒出現的時刻？能，則較可能是技術困難；不能，則較可能是知覺困難。受督者描述那一刻時，若有明顯的不安，要考慮情緒能力或個人反應。
9. 仍缺少的資訊：個案整體的概念化；同盟品質；受督者的訓練背景（可能來自其他取向）。
10. 什麼會改變判斷？若得知個案有暴力風險或危機，焦點轉為內容指導與安全評估。
11. 下一步：選擇任務環境：同理探索受督者的困難，或示範、角色扮演、提供「可以做」的回應，並觀察受督者的學習歷程。

G. 原書示例的應用

以下均為原書本章的示例，整理其教學重點：

- 同理探索的示例（「你回應的是痛，不是憤怒」）：督導者不直接糾正，而是好奇受督者的決策歷程。這讓受督者自己發現錯過了什麼。
- 結構化任務回應的示例（「多一些結構，轉向椅子工作」）：先肯定受督者的同理，再提出具體的任務方向，是一種歷程引導，而不是內容指導。
- 自殺評估的示例：督導者以條列具體問題的方式，要求受督者先完成簡要評估，才繼續其他工作。這是本章最清楚的內容指導範例。
- 開場的示例（「感冒好一點了嗎？」）：關係接觸可以很簡短，但不應省略。

H. 常見誤解與臨床陷阱

1. 把督導當成個案回顧。只口頭報告個案史，而不看錄影中的實際歷程。
2. 把督導當成受督者的治療。在督導中持續處理受督者的個人議題。
3. 以為 EFT 督導從不直接指導。在風險與倫理議題上，內容指導是必要的。
4. 反過來，事事都用內容指導。違反「最少內容指導」原則，也剝奪了受督者自己發現答案的機會。
5. 跳過關係接觸，直接進入錄影。錯過受督者當天的狀態，以及可能更緊急的議題。
6. 只等受督者提出標記。督導者看到的教學點也是正當的標記來源。
7. 只由督導者決定焦點。多個標記同時出現時，應合作決定優先順序。
8. 用督導者的表現評估督導好壞。改變的所在是受督者的歷程。
9. 忽略未解決的議題。同一個困難反覆出現，是同盟裂痕的預警。
10. 只看技術能力。忽略態度、情緒與「對自己的認識」這幾項能力向度。
11. 把受督者的學習當作已知機制。原教材承認這部分尚未被清楚研究，不宜過度推論。

I. 倫理、文化與專業考量

- 個案福祉與倫理實務本身就是督導的兩項目標。督導者在風險議題上要給具體指引；受督者有責任及早提出。

- 評量與權力：評量是依場域而定的目標，而且學習優先於評量。從臨床實務角度看，這不代表評量不存在。受督者清楚知道哪些會被評量、如何被評量，才能在督導中放心地揭露困難。
- 界線：督導不是替代性治療；受督者的個人議題若持續影響工作，應考慮轉介。
- 文化與理論背景：對話要在受督者的參照架構中進行，敏感於其理論訓練背景與個人、文化、專業視角，並找到共通語言。
- 督導者對質受督者：遲到或干擾治療的弱點是正當的督導標記；對質的方式應延續 EFT 的真誠與尊重（第4章會詳述）。
- 錄影與保密（從臨床實務角度）：使用錄影需要個案的知情同意，並遵守機構的保存與銷毀規範。

J. 學習者必須帶走的核心知識

層次	內容
必須記住	五大能力向度；五項督導目標；督導者四類回應，以及歷程引導的五種子類型；事件模型五步驟；標記的四種來源；解決的兩種形式與五個領域
應該理解	為何學習優先於評量；督導不是個案回顧、不是替代性治療、不是僵化指導；為何受督者歷程是改變的所在；為何風險議題需要內容指導
能夠應用	把一次督導切成五步驟；分類督導者回應；準備自己的督導標記；辨識自己的困難屬於人際、技術或同盟
能夠批判性思考	事件模型尚未被實證檢驗；受督者學習歷程的機制不明；「學習優先於評量」在守門責任下的張力

§3 核心概念洞見

洞見一：督導由「事件」組成，是同理之海中的工作之島

- 核心命題：督導不是一段模糊的談話，而是一連串有開始、中間、結尾的事件：接觸 → 標記 → 任務環境 → 受督者歷程 → 解決。這些事件都鑲嵌在同理支持的關係中。
- 臨床重要性：有了事件的結構，督導者與受督者都能知道「我們現在在處理什麼、處理到哪裡了」，避免督導變成泛泛的個案討論。
- 對臨床推理的影響：每次督導都可以問：「這次的標記是什麼？我們建立了什麼任務？解決的樣子是什麼？」
- 例子：受督者說「我抓不到個案核心的批評」（標記）→ 督導者與受督者聽錄影，並角色扮演如何讓批評更具體（任務環境）→ 受督者開始聽出第二層與第一層批評的差別（歷程）→ 受督者能在下次晤談中試用（解決）。
- 常見學生誤解：以為結構化就等於冷冰冰。原教材強調，「島」永遠在「海」之中。
- 教學重點：每一次督導，都試著找出一個清楚的事件。

洞見二：改變的所在是受督者的歷程，不是督導者的表現

- 核心命題：督導者的介入只有在促進受督者的投入與學習時才有效。受督者的歷程，比督導者做了什麼更重要。
- 臨床重要性：這把督導的成效標準，從「督導者說得對不對」轉為「受督者學到了什麼、能做到什麼」。
- 對臨床推理的影響：督導者要持續觀察受督者的反應：他是在投入，還是在順從？受督者也可以自問：我在這次督導中新看見了什麼？
- 例子：督導者講解了一套精彩的理論，但受督者只是點頭；相比之下，另一次督導只停在一個錄影片段，受督者自己聽出了個案聲音的轉變。後者才是有效的督導事件。
- 常見學生誤解：以為督導者講得越多越好。
- 教學重點：督導的成效，以受督者的學習為準。

洞見三：「最少內容指導」不等於「沒有內容指導」

- 核心命題：EFT 督導偏好經驗性的回應，但在倫理、治療設置、自殺風險與嚴重情緒調節不良時，督導者必須直接、具體地指導。
- 臨床重要性：這避免了兩種危險：過度指導造成的學習剝奪，以及在危機中仍堅持「讓受督者自己發現」的失職。
- 對臨床推理的影響：督導者在每個標記處都要先問：「這裡有安全或倫理議題嗎？」有，就先處理；沒有，才進入經驗性的探索。
- 例子：受督者提到個案有想死的念頭時，督導者先停下原本的主題，具體詢問念頭的性質、頻率、計畫、手段與保護因子，要求先完成評估。
- 常見學生誤解：以為 EFT 的歷程取向不重視風險評估。
- 教學重點：安全先於歷程；危機時，督導的語氣要改變。

洞見四：標記可以來自受督者，也可以來自督導者

- 核心命題：標記有四種來源：受督者的兩難、受督者的擔憂（包括非語言）、受督者的直接請求，以及督導者辨識出的教學點。
- 臨床重要性：受督者不必等到「完全知道自己哪裡不會」才能帶東西進督導。一個模糊的擔憂、一次不自在的挪動，都是正當的起點。
- 對臨床推理的影響：受督者可以練習把自己的困惑說成一個標記：「我在 23 分鐘那裡覺得卡住了，不知道是我沒聽懂，還是不知道怎麼回。」
- 例子：督導者在錄影中注意到受督者錯過了個案的一聲嘆氣，就可以把它當作督導者辨識出的教學點提出。
- 常見學生誤解：以為只有「具體問題」才值得帶進督導。
- 教學重點：把困惑說清楚，就是在為督導建立標記。

洞見五：能力不只是技術，還包括態度與情緒

- 核心命題：EFT 的五大能力向度包括關係、態度、技能、情緒與知識，而知識中最重要的是對自己與他人的認識。
- 臨床重要性：一個技術純熟但無法忍受個案情緒的治療師，仍然無法有效地做 EFT。
- 對臨床推理的影響：評估自己的學習時，不只問「我會不會這個技術」，也要問「我能不能忍受模糊？我對哪些情緒感到不自在？」
- 例子：受督者知道空椅的所有步驟，但在個案開始憤怒時就轉移話題。問題不在技能向度，而在情緒能力（忍受情感）。
- 常見學生誤解：以為態度和情緒能力無法訓練。原教材把它們列為督導要發展的目標。
- 教學重點：勝任 EFT，需要技術、態度與情緒能力三者兼備。

§4 關鍵原文引述

引述一

原文：

“islands of work within an ocean of empathic support and validation.”

中文意譯：「在同理支持與驗證之海中的工作之島。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 2, General Description of the EFT Event-Based Model of Supervision, p. 37.

臨床意義：這個比喻把兩件看似矛盾的事放在一起：督導有明確、技術性的工作事件，但這些事件永遠被同理的關係包圍。沒有海，島無法存在；沒有島，海沒有方向。

教學意義：受督者可以用這個比喻檢視督導經驗：這次督導有沒有一個清楚的工作焦點？整體關係是否讓我感到被支持？兩者缺一不可。

引述二

原文：

“it is supervisee processes in supervision that are the site of change; these are more important than what the supervisor does.”

中文意譯：「督導中受督者的歷程才是改變的所在；它們比督導者做了什麼更重要。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 2, Supervisee's Process, p. 41.

臨床意義：這句話把督導的焦點從督導者的表現，轉到受督者的學習。它與 EFT 治療的立場平行：改變發生在個案的經驗歷程中，而不是治療師的技巧中。

教學意義：受督者在督導中的主動參與，例如說出困惑、提問、練習回應，是督導有效的必要條件。受督者不是被動的接收者。

引述三

原文：

“EFT supervision involves neither a case review nor a surrogate therapy for the supervisee.”

中文意譯：「EFT 督導既不是個案回顧，也不是對受督者的替代性治療。」

出處：Greenberg & Tomescu (2017), Chapter 2, Goals of Supervision, p. 33.

臨床意義：這句話清楚劃出督導的兩條界線：督導不是停留在個案資料層次的討論，也不是受督者的個人治療。督導的焦點是錄影中的實際歷程，以及受督者促進個案經驗的技能。

教學意義：受督者可以據此調整對督導的期待：帶錄影，而不只帶個案摘要；個人議題持續影響工作時，考慮個人治療，而不是期待在督導中處理。

§5 臨床推理框架

5.1 督導者在一個督導標記處的八步推理

步驟	問題	本單元的具體做法
① 我現在知道什麼？	可觀察的資料	受督者說了什麼、怎麼說（包括非語言）；錄影中實際發生了什麼
② 我還不知道什麼？	資料缺口	受督者真正的困難是什麼？他嘗試過什麼？他此刻需要什麼？
③ 我正在形成什麼假設？	標記的類型	人際困難（與個案）？技術困難？督導同盟困難？有沒有安全或倫理議題？
④ 有哪些替代解釋？		例如「技術困難」其實是「對某種情緒不自在」（情緒能力）
⑤ 什麼資料可以支持或推翻？		回看錄影；請受督者描述那一刻的感受；請他試著說一句回應
⑥ 下一步應該評估什麼？	選擇任務環境	四類回應中的哪一類？需要示範、角色扮演，還是同理探索？
⑦ 哪些因素可能改變我的判斷？		受督者的反應：是投入，還是順從？有沒有新的風險資訊？

步驟	問題	本單元的具體做法
⑧ 如何轉化成督導決策？	決定解決的樣貌	這個事件的解決是什麼？今天能完成嗎？若未完成，下次如何接續？

5.2 優先順序決策

督導開始 → 關係接觸（受督者今天狀態如何？）



有沒有安全、倫理或設置上的急迫議題？

├ 有 → 內容指導回應：具體評估與處理步驟（例如自殺風險的簡要評估）

└ 沒有 → 合作確認焦點（標記）



標記類型？

├ 人際困難（與個案）→ 同理探索受督者的經驗＋在場回應（第4章）

├ 技術困難 → 歷程引導：結構化任務、歷程建議、示範、練習（第5章）

└ 督導同盟困難 → 真誠、共同承擔、公開討論（第4章）



觀察受督者歷程 → 解決？ — 是 → 鬆一口氣、滿足、重燃熱情

└ 否 → 記下，下次接續；反覆未解決 → 公開討論目標與期待

5.3 受督者版：把困惑整理成一個督導標記

項目	內容
片段時間點	錄影第幾分鐘
發生了什麼（描述）	個案說了什麼、怎麼說；我回應了什麼
我的困難屬於	☐ 人際（與個案的連結） ☐ 技術（介入） ☐ 我自己在那一刻的反應 ☐ 我不確定
標記的形式	☐ 兩難 ☐ 擔憂 ☐ 直接請求
我希望的協助	例如示範、一起聽錄影、練習回應、理解概念
安全或倫理議題？	有的話，在督導開頭先提出

5.4 適用的概念化框架

本單元主要使用事件本位的任務分析框架，對象是督導歷程，而不是個案。從臨床實務角度，它可以與能力本位督導的架構並行：五大能力向度提供受督者發展的評估基準，事件模型則提供每次督導的操作結構。